

Universitätsklinikum Beispielstadt

Medizinische Klinik II – Kardiologie und Angiologie

Klinikstraße 1 · 80331 Beispielstadt

Tel: 089 / 123456-200 · Fax: 089 / 123456-299

E-Mail: kardiologie@uk-beispielstadt.de

An:

Dr. med. Petra Müller
Hausarztpraxis Mitte
Hauptstraße 42
12345 Musterstadt

Beispielstadt, 20. Februar 2026

Unser Zeichen: KA/2026/08847

Ihr Patient: Hans-Werner Becker

Entlassbrief – stationärer Aufenthalt 12.02.2026 bis 19.02.2026

Patient: **Hans-Werner Becker** · geb. **14.03.1952** · Patientennr.: **KH-2026-08847**

Sehr geehrte Frau Kollegin,

wir berichten über den oben genannten Patienten (72 Jahre, männlich), der sich vom 12. bis 19. Februar 2026 zur stationären Behandlung in unserer Klinik befand. Wir danken Ihnen für die freundliche Überweisung.

Diagnosen

1. Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) (ICD: I21.4) — Akutereignis
2. Arterielle Hypertonie, bekannt, medikamentös eingestellt (ICD: I10)
3. Diabetes mellitus Typ 2, bekannt (ICD: E11.9), zuletzt HbA1c 7,8 %

Klinischer Verlauf

Herr Becker stellte sich am 12.02.2026 gegen 03:40 Uhr in unserer Notaufnahme mit akutem Thoraxschmerz, Dyspnoe und Schweißausbrüchen vor. Im 12-Kanal-EKG zeigten sich neue ST-Senkungen in V4–V6 sowie ein neu aufgetretener Linksschenkelblock. Die hochsensitiven Troponinwerte (hsTnI) waren mit 1.842 ng/l (Referenz < 34 ng/l) deutlich erhöht.

Es erfolgte eine notfallmäßige Koronarangiographie, die eine hochgradige (90-prozentige) Stenose des Ramus interventricularis anterior (RIVA) zeigte. Die anderen Koronargefäße waren ohne signifikante Stenosen. Es wurde eine perkutane transluminale Koronarangioplastie (PTCA) mit Implantation eines medikamentenfreisetzenden Stents (DES, 3,0 × 20 mm, Everolimus-beschichtet) durchgeführt. Der Eingriff verlief komplikationslos mit gutem angiographischen Ergebnis (TIMI-3-Fluss).

Der postinterventionelle Verlauf war unkompliziert. Echokardiographisch zeigte sich eine leichtgradig reduzierte linksventrikuläre systolische Funktion (EF 48 %). Eine Verlegung auf die Normalstation erfolgte am 14.02.2026. Die Mobilisation verlief problemlos. Hinsichtlich des Diabetes wurde der behandelnde Diabetologe konsiliarisch hinzugezogen.

Medikation bei Entlassung

Medikament	Dosis	Schema	Hinweis
ASS (Acetylsalicylsäure)	100 mg	1-0-0	dauerhaft

Ticagrelor	90 mg	1-0-1	mind. 12 Monate — NICHT absetzen ohne kardiolog. Rücksprache
Bisoprolol	5 mg	1-0-0	dauerhaft
Ramipril	5 mg	1-0-0	dauerhaft
Atorvastatin	40 mg	0-0-1	dauerhaft
Pantoprazol	40 mg	1-0-0	für 3 Monate
Metformin	500 mg	1-0-1	nach Rücksprache mit Diabetologen fortführen

Empfehlungen / Weiteres Vorgehen

1. Duale Thrombozytenaggregationshemmung (ASS + Ticagrelor) für mindestens 12 Monate unbedingt beibehalten — kein Absetzen ohne vorherige kardiologische Rücksprache. Risiko einer In-Stent-Thrombose bei vorzeitigem Absetzen.
2. Kardiologische Nachkontrolle in 4 Wochen — bitte Überweisung ausstellen. Ziel: Echokardiographie-Kontrolle, EKG, Laborkontrolle.
3. HbA1c-Kontrolle und diabetologische Mitbetreuung in 6 Wochen empfohlen. Metformin-Dosisanpassung je nach Nierenfunktion (aktuell Kreatinin 1,1 mg/dl).
4. Blutdruckkontrolle bei jedem Praxisbesuch. Zielwert systolisch < 130 mmHg.
5. Fahrverbot für 4 Wochen aufgrund des akuten kardialen Ereignisses — Patient wurde darüber aufgeklärt.
6. Laborkontrolle in 2 Wochen: Blutbild, Nierenwerte, Elektrolyte, Transaminasen (Statin-Kontrolle), Lipidstatus.
7. Lebensstilberatung: Nikotinabstinenz, mediterrane Ernährung, körperliche Belastung graduell steigern ab Woche 4, kardiale Rehabilitation empfohlen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen,

Prof. Dr. med. Klaus Herzmann

Leitender Oberarzt, Kardiologie und Angiologie
Universitätsklinikum Beispielsstadt

Dieses Dokument enthält fiktive Patientendaten. Ausschließlich zur technischen Erprobung des hbar.health-Systems erstellt. Kein Bezug zu realen Personen oder Einrichtungen.